

1. PROPÓSITO E ESCOPO DO SOFTWARE

ARTF1. Propósito do software

1. Como se apresenta a realidade hoje da organização e/ou usuários sem o software?

Atualmente, a recepção da UBS (UBS. 06) que fica localizada no Sítio Santa Catarina, Município de Monteiro - PB, a qual a equipe conseguiu uma entrevista com a atual recepcionista, funciona de forma mista entre processos digitais e manuais. Embora exista o sistema, cujo nome é PEC, que tem como objetivo registrar cadastros e fazer agendamentos, a equipe da recepção ainda faz o uso de “fichinhas” de papel, anotações e canetas para organizar a ordem de atendimento e controlar pacientes prioritários. A organização da fila segue principalmente a ordem de chegada, mas pacientes com prioridade, como gestantes, idosos ou casos de urgência, precisam ser atendidos fora da ordem e a reorganização é feita manualmente. Com isso, essa realidade apresenta algumas dificuldades que são enfrentadas no dia a dia, como a lentidão no atendimento nos dias de grande movimento, dificuldade em reorganizar rapidamente a fila quando surgem prioridades de última hora e dependência de anotações manuais, o que aumenta a chance de erros ou perda de informações. Apesar do sistema PEC ter melhorado em relação às fichas, ainda não há uma solução totalmente integrada e eficiente para a visualização completa da fila e gerenciamento automático de prioridades, tornando o trabalho da recepção estressante em dias de grande movimento e sujeito a falhas.

2. Como o software pode agregar valor, melhorando essa realidade?

Considerando a realidade atual da UBS, o sistema Pronto Atende agrega valor ao substituir gradualmente o uso das fichas de papel, reduzindo a dependência de anotações manuais e diminuindo os riscos de erros ou perda de informações. Além disso, o software permitirá uma visualização clara e em tempo real do andamento da fila de atendimento, incluindo o controle de pacientes prioritários, o que facilita a reorganização imediata quando surgem atendimentos de urgência ou casos especiais. Com isso, o Pronto Atende

melhora significativamente a agilidade do atendimento, poderá reduzir o estresse da equipe da recepção, garante que os pacientes prioritários sejam atendidos corretamente e possibilita um gerenciamento mais eficiente dos cadastros e históricos dos pacientes. Dessa forma, ele contribui para um processo mais organizado, ágil e confiável.

3. No geral, esse software servirá para o quê?

O objetivo do Pronto Atende é automatizar e organizar o processo de atendimento inicial dos pacientes em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Seu principal propósito é substituir os procedimentos manuais realizados na recepção, como o uso de fichas de papel e anotações, por um sistema digital integrado que gerencie cadastros, agendamentos e a ordem de atendimento de forma eficiente. Além disso, ele permitirá o controle automático de pacientes prioritários, a visualização em tempo real da fila de espera e atualização imediata das informações, tornando o fluxo de atendimento mais rápido, seguro e transparente tanto para os profissionais quanto para os pacientes.

4. Se necessário, complemente, quais os aspectos ou situações em que esse software não servirá de jeito nenhum ou o que não se tem certeza ainda se deve ele pode vir a servir.

O Pronto Atende não servirá para o registro de informações clínicas dos pacientes, como prontuários médicos, resultados de exames ou prescrições, pois seu foco está exclusivamente na etapa inicial do atendimento realizado na recepção da UBS. O sistema também não conseguirá resolver limitações externas, como o número máximo de atendimentos disponíveis por dia ou até mesmo situações em que os pacientes precisam chegar muito cedo à unidade para garantir atendimento, problemas que ocorrem independentemente da organização digital da fila. Além disso, o software não elimina totalmente a necessidade de atenção e supervisão da equipe da recepção. Mesmo com o controle digital de prioridades e da fila, faz necessário que a equipe acompanhe o atendimento de casos especiais, organize situações inesperadas e garanta que informações incompletas ou

pacientes recém-cadastrados sejam corretamente incluídos na fila. Dessa forma, o Pronto Atende atua como uma ferramenta de apoio, melhorando a organização e a visibilidade da fila, mas não substitui completamente o trabalho humano nem resolve todas as limitações da UBS.

2. ESTUDO DE VIABILIDADE

ARTF1. Matriz de viabilidade

PERSPECTIVA	ANÁLISE DA VIABILIDADE
VIABILIDADE FINANCEIRA ¹	O sistema será desenvolvido por uma equipe de estudantes da disciplina de PJ1, utilizando recursos que todos possuem e que também são disponibilizados pela instituição, como computadores e software gratuitos. Como o desenvolvimento será acadêmico, não haverá custos diretos com licenças ou infraestrutura. Viabilidade financeira: muito alta
VIABILIDADE LEGAL ²	Não há restrições legais que impeçam o desenvolvimento do sistema, pois ele seguirá os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o sigilo e a segurança total das informações pessoais dos pacientes, além das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), que assume o uso ético e responsável de dados em sistemas de informação em saúde. Viabilidade legal: alta
VIABILIDADE TÉCNICA ³	A equipe possui conhecimento básico em linguagens como Java com Spring Boot, JavaScript, TypeScript, React, noções de banco de dados e de testes e entre outros. As ferramentas citadas são de uso gratuito, o que fortalece ainda mais o desenvolvimento do produto. Portanto, esses conhecimentos já são um pouco suficientes para o desenvolvimento da aplicação proposta. Viabilidade técnica: alta

1

2

3

VIABILIDADE TEMPO ⁴	Considerando que o desenvolvimento completo ocorrerá na disciplina de Projeto 2, o tempo de execução é adequado para o escopo do sistema. Nesta etapa (Projeto 1), o foco é a documentação, o que favorece um planejamento detalhado e organizado. Viabilidade de tempo: alta
CONCLUSÃO (É possível prosseguir com o desenvolvimento do produto?)	O projeto apresenta alta viabilidade sob os aspectos financeiro, legal, técnico e temporal. Com isso, a execução é plenamente possível e deve trazer benefícios reais às unidades de saúde, modernizando e melhorando a qualidade no processo de atendimento na recepção e dos pacientes.